Deux biomarqueurs sanguins : que peut-on en conclure ?

Synthèse pour un public non statisticien

Guy Darcy Remesha · 3 novembre 2026

À retenir. Ces deux marqueurs sont bien liés au risque, mais leur utilité pour une décision individuelle n'est pas démontrée. Un lien statistique et une utilité clinique sont deux questions différentes.

Ce qui a été étudié

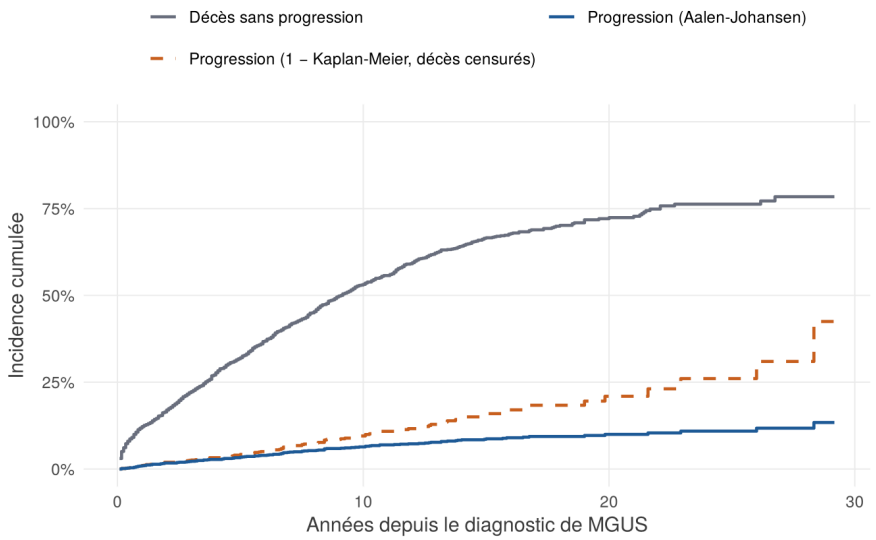
Deux jeux de données publics de la Mayo Clinic ont été analysés : 7 871 habitants de 50 ans ou plus, et 1 384 personnes atteintes de MGUS, une anomalie sanguine souvent sans symptôme qui peut rarement évoluer vers une maladie comme le myélome.

Chaînes légères libres et mortalité

- **Résultat :** quand le taux de FLC double, le risque de décès à un instant donné augmente d'environ 71 %, à âge, sexe et fonction rénale comparables.
- **Exemple :** pour une femme de 65 ans à la fonction rénale normale, le risque de décès à 10 ans est estimé à 12 % avec un taux bas et à 16 % avec un taux élevé (quartiles de la population).
- **Limite :** l'âge permet déjà de bien estimer ce risque. Le FLC n'ajoute qu'une amélioration modeste, sous l'objectif fixé à l'avance. Il semble refléter l'état de santé général plutôt qu'une maladie précise.
- **Décision proposée :** réorienter vers des situations où ce marqueur pourrait changer une décision.

Pic monoclonal et évolution de la MGUS

- **Résultat :** le risque d'évolution à 20 ans est de 17 % si le pic atteint 1,5 g/dL, contre 7 % en dessous.
- **Point de méthode important :** beaucoup de patients décèdent d'une autre cause avant toute évolution. Si l'on ignore ce fait, le risque à 20 ans est surestimé : 21 % au lieu de 10 %.
- **Limite :** avec seulement 112 évolutions analysées, le gain apporté pour classer les patients reste trop incertain.
- **Décision proposée :** valider le résultat dans une cohorte plus grande avant d'en faire un outil de stratification.



Ce que ces résultats ne disent pas

Ces analyses ne prouvent pas que ces marqueurs causent la maladie ou le décès. Elles ne disent rien de la réponse à un traitement et ne concernent que des populations américaines. Une validation dans d'autres populations reste nécessaire.